

Palpitation

Anamnèse

1. Caractériser les palpitations
 - a. **Localisation** (cou)
 - b. Qualité
 - i. **Bat très vite**
 - ii. **Fort mais lent**
 - iii. **Régulier/irrégulier**
 - c. Facteurs aggravants / soulageants
 - d. Chronologie
 - i. Depuis quand
 - ii. **Début brusque ?**
 - iii. Évolution
 - iv. Condition de survenues
 1. Repos / effort
2. Symptômes associés
 - a. **Douleurs thoraciques**
 - b. **Dyspnée**
 - i. Condition de survenue
 - ii. Classification (périmètre de marche, nb étage etc)
 - iii. Chronologie
 - c. Toux
 - i. Depuis quand
 - ii. Fréquence
 - iii. Qualité (sèche, grasse)
 - iv. Expectoration
 1. Couleur
 2. Sang
 - d. Œdèmes des membres inférieurs
 - e. Orthopnée
3. **Syncope**
4. ATCD et comorbidités
 - a. Maladie
 - b. Hospitalisations
 - c. Opération (récente ?)
 - d. Médicaments
 - e. Allergies
5. ATCD familiaux

Examen clinique

1. Inspection
 - a. Extrémités (ongles)
 - b. Langue
 - c. Recoloration capillaire
 - d. Thorax et mouvements
 - e. Oedèmes des MI (godet)
 - f. Turgescence jugulaire
 - i. Reflux hépato-jugulaire (> 10s)
2. Cardiaque
 - a. Palpation
 - i. Pouls périphériques aux 4 extrémités
 - ii. Carotidien (**!!! auscultation avant**)
 - iii. Choc de pointe
 - b. Auscultation
 - i. Aortique
 - ii. Pulmonaire
 - iii. Mitral
 - iv. Tricuspidé
 - v. Recherche souffle abdominal
 - vi. Recherche souffles fémoraux
3. Pulmonaire
 - a. Palpation
 - i. Zone douloureuse (reproductible à la palpation ?)
 - ii. Ampliation thoracique (post)
 - b. Percussion (post + lat)
 - i. Délimiter
 - ii. Comparer les deux côtés
 - c. Auscultation
 - i. Postérieure : 4 plages en comparant
 - ii. Latérales : 2 plages

Prise en charge

- Faire ECG

DD

- *Bradyarythmies (palpitation lente)*
- *Fibrillation auriculaire (AVC, signes IC)*
- *Flutter auriculaire (AVC, signes IC)*
- *Tachycardie auriculaire (signes IC)*
- *Tachycardie supraventriculaire par réentrée nodale (cou, début et fin brusque)*
- *Tachycardie ventriculaire (FC : 150-200 mais hypotension)*